

J'ai pas fait pour le chat : trop compliquer pour lui donner des médicaments 😊

Pour le cheval analyse à faire

compléments utiles dans les allergies du chien

1. Oméga-3 (EPA/DHA – huile de poisson purifiée)

Mécanisme

Modulation de la voie des eicosanoïdes → diminution des médiateurs pro-inflammatoires (LTB₄, PGE₂). Effet cortico-sparing démontré.

Indication principale

Dermatite atopique chronique. Peu d'intérêt isolé en allergie aux puces. Rôle adjuvant en allergie alimentaire.

Niveau de preuve

Bon (plusieurs études cliniques contrôlées).

Délai d'action

6–8 semaines.

Dose efficace

100–150 mg/kg/j d'EPA+DHA combinés.

Impact clinique réel

Réduction modérée mais significative du prurit (≈15–30 %). Permet parfois de réduire doses d'occlacitinib ou corticoïdes.

Positionnement stratégique

Base nutraceutique de fond dans l'atopie.

2. Soutien barrière cutanée (complexes lipidiques, céramides)

Mécanisme

Restauration de la couche lipidique épidermique → réduction perte hydrique transépidermique.

Indication principale

Dermatite atopique.

Niveau de preuve

Modéré (plus solide en topique qu'en oral).

Délai d'action
2–4 semaines.

Impact clinique réel
Amélioration qualité cutanée, réduction récurrences secondaires (pyodermites légères).

Coût
Modéré.

Positionnement stratégique
Complément structurel, surtout utile en phase de maintenance.

3. Probiotiques ciblés (Enterococcus faecium, Lactobacillus rhamnosus...)

Mécanisme
Modulation axe intestin-immunité → influence réponse Th2.

Indication principale
Allergie alimentaire ou atopie avec troubles digestifs associés.

Niveau de preuve
Variable selon souche (hétérogène).

Délai d'action
4–8 semaines.

Impact clinique réel
Bénéfice léger à modéré, dépendant fortement de la souche et du patient.

Coût
Faible à modéré.

Limites
Marché peu standardisé. Tous les produits ne sont pas équivalents.

Positionnement stratégique
Option intéressante dans approche intégrative, surtout terrain digestif sensible.

4. Palmitoléthanolamide (PEA)

Mécanisme
Stabilisation mastocytaire, modulation neuro-inflammatoire.

Indication principale
Prurit léger à modéré chronique.

Niveau de preuve
Modéré mais cohérent.

Délai d'action
3–6 semaines.

Impact clinique réel
Effet discret mais mesurable. Utile en stratégie cortico-sparing.

Coût
Modéré.

Limites
Ne remplace pas traitement anti-IL-31 ou JAK en cas sévère.

Positionnement stratégique
Intéressant en entretien ou formes légères.

5. Antioxydants (Vitamine E, polyphénols)

Mécanisme
Réduction stress oxydatif cutané.

Niveau de preuve
Faible isolément.

Impact clinique réel
Faible seul ; utile en association.

Positionnement stratégique
Complément secondaire, rarement prioritaire.

Hierarchisation pratique (dermatite atopique)

Priorité 1
Oméga-3 de qualité pharmaceutique.

Priorité 2
Soutien barrière cutanée (topique en particulier).

Priorité 3
PEA en stratégie de réduction médicamenteuse.

Option ciblée
Probiotiques si suspicion implication digestive.

Peu prioritaire
Antioxydants seuls.

